Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Judicial da Comarca de Rio Pardo

Rua Moinhos de Vento, 60 - Bairro: Fortaleza - CEP: 96640000 - Fone: (51)3098-5790 - Balcão Virtual (51) 99745-2933 - Email: frriopardo2vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002470-16.2022.8.21.0024/RS

AUTOR: GECILDA CATARINA DE SOUZA SANTOS

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos.

GECILDA CATARINA DE SOUZA SANTOS ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL. Relatou ser conveniada ao plano de saúde IPE do Estado do Rio Grande do Sul e que foi diagnosticada com Adenocarcinoma de Cólon Direito Metastático (CID 10 - C18), necessitando fazer uso do tratamento por meio do protocolo FOLFIRI + AVASTIN (Bevacizumabe) a cada quatorze dias por 12 ciclos. Postulou a procedência da ação para o fim de determinar que o demandado forneça o tratamento, inclusive liminarmente. Pediu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Anexou procuração.

Concedida a gratuidade de justiça e deferida a medida liminar (evento 3, DESPADEC1).

Citado, o demandado apresentou contestação (evento 20, CONT1), discorrendo, em síntese, sobre o sistema do IPE SAÚDE e da legislação aplicável. Referiu que qualquer tratamento a ser disponibilizado pelo IPE Saúde carece de previsão normativa inequívoca, o que não acontece neste caso, já que o Instituto não prevê a cobertura para o tratamento oncológico com o medicamento solicitado. Teceu considerações acerca do direito aplicável à espécie. Pugnou pela improcedência da ação.

Houve réplica (evento 23, RÉPLICA1).

Intimadas as partes a se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas, nada foi requerido.

Sobreveio pedido de tutela de urgência para substituição do fármaco pleiteado inicial (evento 33, PET1).

Concedida a tutela requerida (evento 36, DESPADEC1).

Vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

O feito apresentou tramitação regular, e não havendo nulidades a serem declaradas ou preliminares pendentes de análise, estando presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo, além de reunidas as condições da ação, procedo ao exame do mérito.

Trata-se de ação em que a parte autora postula o fornecimento de tratamento de saúde, em razão da sua hipossuficiência, por ser portadora de Adenocarcinoma de Cólon Direito Metastático (CID 10 - C18), necessitando fazer uso dos fármacos *"LONSURF (CLORIDRATO DE TIPIRACILA + TRIFLURIDINA) 15 MG, 80 comprimidos (04 comprimidos pela manhã e 04 à noite do D1-D5 e do D12-D15 a cada 28 dias), e BEVACIZUMABE (AVASTIN) 300 MG, aplicação EV a cada 14 dias"* (evento 33, DOC1).

Observa-se que a negativa administrativa do IPE-Saúde em fornecer o tratamento, através do uso das medicações postuladas, baseia-se exclusivamente na alegação de que o tratamento não encontra previsão nas recomendações técnicas: (evento 1, DOC10):

Indeferimento da solicitacao 17/06/2022

Tratamento não previsto nas recomendações técnicas

Todavia, a autora comprovou, através do atestado médico, que tem diagnóstico de Adenocarcinoma de Cólon Direito Metastático (CID 10 - C18), necessitando ser submetida a tratamento por meio dos medicamentos pleitados nos autos (evento 33, DOC2):

LAUDO MÉDICO

Paciente com adenocarcinoma de cólon em 2020 CID 10 C18. Realizou colectomia direita e tratamento adjuvante com FOLFOX por 11 ciclos até 12/2021 (suspenso último ciclo devido neuropatia periférica).
Em junho de 2022 apresentou recidiva retroperitoneal.
Kras (Amgen) 05.07.22: selvagem
Neste momento foi iniciado primeira linha de tratamento paliativo com FOLFIRI + Avastin (de 27.06.22 a 02.12.22). Apresentou ótima resposta e pode-se dar pausa ao tratamento.
Em abril de 2023 apresentou recidiva de baixo volume sendo instituído tratamento com capecitabina a qual realizou de 08.05.23 a 16.01.24.
Em janeiro de 2024 apresentou nova progressão sendo reexposta à oxaliplatina com protocolo FOLFOX + panitumumabe, o qual realizou até agosto de 2024.
Atualmente com nova progressão de doença. Painel genético germinativo negativo e estabilidade de microssatélite.
Neste momento paciente necessita fazer uso do medicamento Lonsurf e bevacizumabe, conforme doses e periodicidades descritas abaixo.
O tratamento deverá ser realizado até progressão da doença ou intolerância.
O tratamento deve ser iniciado de imediato, sob risco de progressão da doença para outros órgãos e morte.

Prescrição:
Lonsurf 15 mg --- 80cp (via oral)
Tomar 04 cp manhã e 04 cp noite do D1-D5 e do D12-D15 a cada 28 dias.

Bevacizumabe 300 mg
Aplicar EV a cada 14 dias

Em sua contestação, o réu alegou, em síntese, que o fornecimento do tratamento oncológico postulado não é contemplado pelas tabelas do Instituto, não podendo o demandado arcar com tais custos.

Contudo, o demandado não apresentou impugnação técnica, firmada por médico, quanto à indicação das terapias prescritas pela médica assistente para o tratamento do quadro clínico da autora.

No ponto, a negativa só pode ser acolhida quando devidamente fundamentada, pois, assim não sendo, desconsidera a indicação dos médicos assistentes, profissionais com melhor capacidade de definir o melhor tratamento para o seu paciente.

Com efeito, entre as partes existe vínculo de direito público, regido pela Lei Complementar Estadual nº 15.145/2018, que reorganizou o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos do Rio Grande do Sul e, no que importa à causa, assim estabeleceu:

> *Art. 2º É objetivo primordial do Sistema IPE Saúde a realização das operações de assistência à saúde aos servidores públicos dos Poderes de Estado, órgãos e entidades autônomas, previstas nas tabelas de cobertura do IPE Saúde, na forma prevista e autorizada nesta Lei Complementar, no respectivo Regulamento e nos atos normativos expedidos pelo Instituto.*
>
> *§ 1º O Sistema de que trata o "caput" deste artigo é fundamentado nos princípios da coparticipação financeira dos usuários e da prestação de serviços de assistência médica, mediante credenciamento de profissionais e pessoas jurídicas da área da saúde. (...)*
>
> *Art. 4º O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor.*

Apesar de a norma vigente, em princípio, estipular a exclusão de procedimentos não contemplados nas tabelas administrativas, é inegável que o sistema expressamente prevê a cobertura de despesas relativas a atos necessários ao tratamento de seus usuários.

Vale dizer, escudar a negativa por falta de previsão nas suas tabelas e resoluções sem justificativa torna a garantia de assistência à saúde uma não-garantia, pois deixa ao arbítrio exclusivo da discricionariedade do administrador definir o que será fornecido. O servidor e seus dependentes ficam em total insegurança, porquanto não têm qualquer ingerência na formulação das escolhas do administrador para a fixação de quais tratamentos serão ofertados.

A negativa só pode ser acolhida quando devidamente fundamentada, pois, assim não sendo, desconsidera a indicação do médico assistente, profissional com melhor capacidade de definir o melhor tratamento para o seu paciente. Portanto, não se pode ignorar a justificativa do médico assistente quanto à indicação do procedimento postulado.

Assim, a responsabilidade de o IPE Saúde de fornecer o tratamento postulado tem fundamento no próprio comando legal.

Nesse sentido:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PEMBROLIZUMAB (KEYTRUDA®) PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. Apelo da parte autora: Hipótese dos autos em que o recurso versa exclusivamente acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, o procurador da parte autora não é beneficiário da gratuidade judiciária, não tendo efetuado o preparo no ato da interposição da apelação (art. 99, §5º, do CPC), tampouco atendido à determinação para proceder ao pagamento em dobro, na forma do art. 1007, §4º, do CPC/15, é caso de não conhecimento do recurso, porquanto deserto. Apelo da parte ré: Fornecimento de medicamento fora dos protocolos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.* ***Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas.*** *Taxa Única de Serviços Judiciais. Considerando a data do ajuizamento da ação, conforme Ofício-Circular n. 060/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, aplica-se, ao caso dos autos, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei 14.634/2014, o qual isenta a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa única de serviços judiciais, observado, contudo, o disposto no parágrafo único do art. 5º da referida lei, bem como as orientações do Ofício-Circular n. 060/2015. Atualização monetária da verba honorária. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), firmaram as teses acerca dos índices de atualização monetária nas condenações*

impostas à Fazenda Pública. No caso dos autos, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser atualizado pelo IPCA-E acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. APELO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70083558205, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 22-04-2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER CARFILZOMIBE (KYPROLIS). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ***A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários. Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado.*** *Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do medicamento solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a reforma da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50209702320238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 31-05-2023) (grifei)*

Por conseguinte, tenho que merece acolhimento a pretensão apresentada pela parte autora.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por GECILDA CATARINA DE SOUZA SANTOS contra o IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL, para confirmar os efeitos da tutela provisória e determinar o fornecimento do tratamento com os medicamentos LONSURF (CLORIDRATO DE TIPIRACILA + TRIFLURIDINA) 15 MG e BEVACIZUMABE (AVASTIN) 300 MG à requerente, nos moldes prescritos na receita médica juntada aos autos.

Ainda, deverá a parte autora apresentar laudo médico atualizado a cada seis meses.

Considerando que a ação foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei n° 14.634/14, o demandado está isento do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 5° da Lei n. 14.634/14. Contudo, não se exime de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (exceto em caso de a parte ser beneficiária da justiça gratuita, quando não existe despesa a ser reembolsada).

Sucumbente, condeno a parte ré a pagar honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado pelo IGP-M desde a data da propositura da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do trânsito em julgado, considerando o labor desenvolvido pelos profissionais e a natureza da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, §2º e §16º, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente. Agendada intimação eletrônica.

No caso de apelação voluntária, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões em até 15 dias; e, decorrido o prazo com ou sem essas, remetam-se os autos à Superior Instância, responsável pela análise da admissibilidade, por determinação do art. 1.010, §3º, do CPC.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3º, do CPC, eis que ilíquida a condenação.

Com o trânsito, nada pendente, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **CLEUSA MARIA LUDWIG, Juíza de Direito**, em 22/10/2025, às 18:25:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10093673930v3** e o código CRC **9430322b**.